सत्र सञ्चालन: कठिन रातहरू

मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (PFA) को तालिम लिएका, सुपरिवेक्षक भएका र प्रेषण (रेफरल) को बाटो थाहा भएका व्यक्तिहरूका लागि ।



तत्काल खतरा छ? सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।



पोस्टर A3



पर्चा, तीन पट्ट

तपाईंका सामग्रीहरू

पोस्टर · सबैको साझा ध्यान

समूहका लागि: छलफल सुरु गर्न, मानिसहरूले देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । सबैले देख्न सक्ने बनाउनुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

पर्चा · घर लैजाने विस्तृत जानकारी

कुनै प्रश्न आएमा वा नजिकबाट हेर्न, र आफूसँग राख्न वा अरूलाई दिन । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस् र सँगै पढ्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, मानिसलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।

मानिसहरू आउनुअघि

- ☐ कुराकानी सुन्नुअघि मात्र होइन, दिउँसोको उज्यालोमा, आयोजकको अनुमति लिएर सुरक्षित, शान्त र सबैले पुग्न सक्ने ठाउँमा गर्नुहोस् । सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् ।
- ☐ पृष्ठ २ मा सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्; जाँच नगरिएका सम्पर्क भएका पर्चा नबाँड्नुहोस् । अझै जोखिम छ भने स्थानीय पूर्वचेतावनी प्रणाली र चेतावनी आएमा कहाँ जाने भनेर जाँच्नुहोस् ।
- ☐ भाषा र पहुँचको योजना बनाउनुहोस्: सरल शब्द, ठूला अक्षर, थप समय, वा आवश्यक र उपलब्ध भए साङ्केतिक भाषा दोभाषे । चित्र वा लेख बुझ्न वा हेर्न कठिन भए अरू विकल्प दिनुहोस् ।

सत्र

करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

उद्देश्य: हरेक व्यक्तिलाई कहिले सहयोग माग्ने भन्ने थाहा होस् र आज राति प्रयास गर्ने एउटा कुरा छानोस्; समूहले यहाँका रातहरूका लागि एउटा परिवर्तन तय गरोस् ।

1 स्वागत र उद्देश्य बताउने

२ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् आफ्नो परिचय दिनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो; कसैले बोल्नु वा आफ्ना रातहरू वा के भयो भन्नेबारे कुरा गर्नुपर्दैन ।

भन्नुहोस्

> *"स्वागत छ । आज हामी पीडादायी अनुभवपछिको निद्रा र रातहरूबारे, र रातलाई अलि सजिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुरा गर्नेछौं ।"*

2 सँगै चित्र हेर्ने

३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

गर्नुहोस् मिलन र उनका बुबालाई, अनि उनीहरू वरिपरिको कोठालाई देखाउनुहोस् । मौनता र फरक-फरक उत्तरलाई ठाउँ दिनुहोस् । पर्चा मात्र भए त्यसको आवरण प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"यो चित्रमा के भइरहेको छ?"*

भन्नुहोस्

> *"धेरै दुःखद घटनापछि धेरै मानिसलाई राम्रो निद्रा पर्दैन वा डराएर ब्युँझिन्छन् । अरूको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सहयोग माग्न के भयो भनेर बताउनुपर्दैन ।"*

3 रातमा केले सहयोग गर्छ भनेर खोज्ने

५ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

गर्नुहोस् *"रात पर्नुअघि"* र *"डराएर ब्युँझिँदा"* हेर्नुहोस् । हरेक सुझाव यहाँ सम्भव छ कि छैन भनेर सँगै जाँच्नुहोस्: बत्ती, आवाज, ठाउँ, गोपनीयता । सास फेर्ने अभ्यास ऐच्छिक हो; कसैलाई झन् नराम्रो लागेमा रोक्नुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"यहाँ रातमा आराम गर्न केले सजिलो बनाउँछ? हामी सँगै के बदल्न सक्छौं?"*

4 सहयोग पाउने बाटो स्पष्ट पार्ने

३ मिनेट · सम्बन्धित सहयोग भाग

गर्नुहोस् कुनै पनि सामग्रीको सहयोग भाग प्रयोग गर्नुहोस् । स्थानीय रूपमा जाँच गरिएको सम्पर्क र सहयोगसम्म कसरी पुग्ने भनेर बताउनुहोस् । अझै जोखिम छ भने तपाईंले जाँचेको स्थानीय चेतावनी योजना बताउनुहोस् । निजी कुराकानीको प्रस्ताव गर्नुहोस्; चिन्ताको कुरा आएमा पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

भन्नुहोस्

> *"निद्राको समस्या लम्बिएर दिनहरू गाह्रो बनाएमा तपाईं सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले पर्खनुपर्दैन ।"*

सोध्नुहोस्

> *अझै जोखिम छ भने मात्र: "आज राति चेतावनी आयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?"*

5 बुझाइ जाँच्ने र समापन

२ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

गर्नुहोस् पर्चा दिनुहोस् र *"रातमा बालबालिका"* र *"कहिले सहयोग माग्ने"* देखाउनुहोस् । समूहको सुझाव आश्रयस्थलका व्यवस्थापकसम्म कसले पुऱ्याउने भनेर तय गर्नुहोस् । मानिसहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र तपाईंलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ भनेर बताउनुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"आज राति तपाईं कुन एउटा कुरा प्रयास गर्नुहुन्छ?"*

सुरक्षा, प्रेषण र कार्यकर्ताका सीमाहरू

कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

संकेतहरू

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन

के गर्ने

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

कोही विचलित भएमा

- शान्त रहनुहोस् र नजिकै बस्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुहुन्छ भने समूहबाट टाढा अलि शान्त ठाउँ दिनुहोस् ।
- बोल्न कर नगर्नुहोस् । अहिले उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुभएसम्म, वा उहाँले विश्वास गर्ने कोही साथमा नआएसम्म बस्नुहोस् ।

PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने

हेर्ने: सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
सुन्ने: आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
जोड्ने: आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- भावनाहरू झन् गाह्रा हुन्छन्, सुधार हुँदैनन्, वा दैनिक जीवन धेरै कठिन बनाउँछन्
- आफ्नो वा आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्नुहुन्न
- शरीरको कुनै समस्याले चिन्तित बनाएको छ: दुखाइ, ज्वरो, चोटपटक, वा धेरै दिनसम्म खान वा सुत्न नसक्नु

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

✓ गर्नुहोस्

- ✓ सरल शब्द प्रयोग गर्नुहोस् र मौनताको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ हरेक सुझाव यहाँ सम्भव छ कि छैन भनेर पहिले जाँच्नुहोस्
- ✓ व्यावहारिक समस्याहरू (शौचालयसम्मको बत्ती, आवाज, ठाउँ) आश्रयस्थलका व्यवस्थापकसमक्ष उठाउनुहोस्
- ✓ सोध्ने जोकोहीसँग पछि निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस्

✗ नगर्नुहोस्

- ✗ खतरा फेरि आउँदैन, मानिसहरू सुरक्षित छन्, वा निद्रा छिट्टै सामान्य हुन्छ भनेर वाचा नगर्नुहोस्
- ✗ निद्राको औषधि नदिनुहोस् वा सुझाव नदिनुहोस्
- ✗ समूहका अगाडि कसैलाई नराम्रा सपना वा के भयो भनेर बताउन नलगाउनुहोस्
- ✗ कसैलाई उहाँको अनुभव *"ट्रमा"* थियो कि थिएन भनेर नसोध्नुहोस्
- ✗ कसैलाई उहाँको डर मूर्खतापूर्ण हो भनेर नभन्नुहोस्

तपाईंको भूमिका



यो निर्देशिकाले सत्र सञ्चालनमा सहयोग गर्छ; यसले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको तालिमको ठाउँ लिँदैन । आफ्नो तालिम, सुपरिवेक्षक र थाहा भएका प्रेषणका बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस्: विश्राम लिनुहोस्, आफ्ना सुपरिवेक्षक वा सहकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, र चाहिएको बेला सहयोग माग्नुहोस् ।

यस क्षेत्रका सहयोग सम्पर्कहरू कुराकानी अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्



स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था _____

तत्काल सहयोग _____

अन्य सहयोग _____

स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Doing What Matters in Times of Stress (2020); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015) । यो सामग्री यी प्रकाशनहरूमा आधारित छ; यसलाई WHO वा IASC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् ।

यो सामग्री केका बारेमा हो

यो अध्याय पीडादायी अनुभवपछिका निद्राका समस्याबारे हो, जसमा आघातपूर्ण हुन सक्ने घटनाहरू पनि पर्छन् । पोस्टर र पर्चामा *"पीडादायी अनुभव"* भनिएको छ, ताकि के भयो त्यो ट्रमा (आघात) *"गनिन्छ"* कि गनिँदैन भनेर पहिले निर्णय नगरी मानिसहरूले जानकारी प्रयोग गर्न र सहयोग माग्न सकून् । यो सरल शब्दको छनोट मात्र हो: यसको अर्थ अनुभव आघातपूर्ण थिएन भन्ने होइन, र यो निदान पनि होइन ।

शब्द कुञ्जी

पोस्टर वा पर्चामा	हाम्रो अर्थ	कुराकानीमा कसरी सम्हाल्ने
"पीडादायी अनुभव"	धेरै दुःखद अनुभवहरू, आघातपूर्ण हुन सक्ने घटनाहरूसमेत	आफैंले *"ट्रमा"* शब्द नल्याउनुहोस् । सहभागीहरूले यो शब्द प्रयोग गरेमा नसच्याई र निदान नगरी स्वीकार गर्नुहोस्, र उहाँहरूको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस् (तल हेर्नुहोस्)
"राम्रो निद्रा नपर्ने वा डराएर ब्युँझिने"; *"नराम्रा सपना"*; *"सतर्क भएर जागा बस्ने"*	तनाव प्रतिक्रियाका रूपमा निद्राका समस्या, नराम्रा सपना र रातमा बढेको सतर्कता	आफैंमा PTSD वा अरू कुनै अवस्था होइन । लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवनमा असर गरे समयमै सहयोग
"वरिपरिका सुरक्षित कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्"	वर्तमान क्षणमा फर्काउने (grounding) तरिका	विकल्पका रूपमा दिनुहोस्; कसैलाई झन् नराम्रो लागेमा रोक्नुहोस्
"अझै जोखिम छ भने स्थानीय चेतावनी हेर्नुहोस्"	आश्वासन होइन, यथार्थपरक सुरक्षा योजना	मानिसहरू सुरक्षित छन् वा खतरा फेरि आउँदैन भनेर कहिल्यै नभन्नुहोस्

सामान्य प्रतिक्रियाहरू, र कहिले थप हेर्ने

पहिलो केही दिन र हप्ताहरू

पीडादायी अनुभवपछि निद्रा नलाग्नु, नराम्रा सपना देख्नु र रातमा सतर्क भइरहनु सामान्य हो । यी तनाव प्रतिक्रिया हुन्, निदान होइनन् । पहिलो महिनाका निद्राका समस्याका लागि WHO ले शिथिलीकरण (relaxation) का तरिका र निद्राका बानीबारे सल्लाह सिफारिस गर्छ ।

घटनाको करिब एक महिनापछि

निद्रामा कुनै सुधार नभएमा, झन् बिग्रँदै गएमा, वा थकाइले दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । एक महिनाभन्दा बढी रहने नराम्रा सपना वा घटना फेरि भोगेजस्तो अनुभवको मूल्याङ्कन स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्छ ।

जुनसुकै बेला

खतरा छ भने अहिले नै सहयोग लिनुहोस् (पृष्ठ २) । कोही संघर्ष गरिरहेको छ वा सहयोग माग्छ भने जुनसुकै बेला समयमै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुहोस्: कसैले एक महिना पर्खनुपर्दैन ।

ध्यानमा राख्नुहोस्

- मानिसहरूको प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन्छ । निद्राको समस्या मात्रले PTSD वा अरू कुनै अवस्था भएको जनाउँदैन ।
- सहयोग पाउन कसैले के भयो भनेर बताउनुपर्दैन । व्यक्तिलाई अहिले के चाहिन्छ, उहाँको सुरक्षा, उहाँले रुचाउने सहयोग र सहयोगसम्म कसरी पुग्ने भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।
- तीन तहलाई छुट्टै राख्नुहोस्: दैनिक सहयोग, समयमै सहयोग माग्ने, र अहिले नै सहयोग लिने ।
- निद्रा सामान्य हुन्छ भनेर, वा कति समय लाग्छ भनेर वाचा नगर्नुहोस् ।

सन्दर्भका लागि मात्र

Chronic insomnia (दीर्घ अनिद्रा; ICD-11, 7A00): सुत्ने पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि निदाउन वा निदाइरहन लगातार कठिनाइ, दिनको काममा असरसहित, हप्तामा कम्तीमा केही पटक, कम्तीमा तीन महिनासम्म; छोटो अवधिका घटनालाई short-term insomnia (अल्पकालीन अनिद्रा; 7A01) मानिन्छ ।

निद्राको औषधि: आघातपूर्ण हुन सक्ने घटनापछिको पहिलो महिनामा तीव्र तनावका लक्षण वा निद्राका समस्या कम गर्न benzodiazepine दिनु हुँदैन भनी WHO ले सल्लाह दिन्छ । सहजकर्ताले कहिल्यै निद्राको चक्की सुझाव दिँदैनन्; उनीहरू व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्छन् ।

यी शब्द सहभागीहरूसँग प्रयोग नगर्नुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् ।

कसैले *"ट्रमा"* भनेमा · उदाहरण: अभ्यास कार्डहरू, पृष्ठ ४

शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । उहाँको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"* मानिसहरूले प्रायः यो शब्द कुनै खास डर वा परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै *"फेरि बाढी आउला भनेर घर फर्कन डर लाग्छ"* वा *"भूकम्प आउला भनेर"* । यस्तो डर डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछिको सामान्य प्रतिक्रिया हो । व्यक्तिले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Guidelines for the management of conditions specifically related to stress (2013); WHO, mhGAP module: Assessment and management of conditions specifically related to stress (2013); WHO, ICD-11, 7A00 Chronic insomnia and 7A01 Short-term insomnia; American Psychiatric Association, DSM-5-TR (2022) ।

अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

कसैले “ट्रमा” भनेमा

> *“यो मेरो ट्रमा हो । हरेक आवाजमा म ब्युँझिन्छु ।”*

एउटा शब्दबाट तपाईंले प्रतिक्रिया दिन सक्ने ठोस परिवर्तनसम्म (पृष्ठ ३, *“कसैले ‘ट्रमा’ भनेमा”*) ।

1 उहाँको अर्थ सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस् *“तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? रातमा के हुन्छ?”*

उहाँ भन्नुहुन्छ *“कोही चल्दा वा ढोका ढ्याप्प लाग्दा म झस्केर उठ्छु । फेरि पानी आउँदैछ जस्तो लाग्छ ।”*

2 प्रतिक्रियालाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस् *“तपाईंले जे भोग्नुभयो, त्यसपछि रातमा सतर्क रहनु सामान्य प्रतिक्रिया हो । धेरै मानिसलाई राम्रो निद्रा पर्दैन वा डराएर ब्युँझिन्छन् ।”*

3 उहाँलाई शान्त हुन केले सहयोग गर्छ खोज्नुहोस्

सोध्नुहोस् *“यसरी ब्युँझिँदा तपाईंलाई अलिकति भए पनि शान्त हुन केले सहयोग गर्छ?”*

गर्नुहोस् पर्चाको *“डराएर ब्युँझिँदा”* भाग हेर्नुहोस्: आफू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ध्यान दिने, बिस्तारै सास फेर्ने, विश्वासिलो मानिसकहाँ जाने ।

4 अझै जोखिम छ भने मात्र चेतावनी योजना जाँच्नुहोस्

गर्नुहोस् उहाँलाई स्थानीय चेतावनी योजना र कहाँ जाने भन्ने थाहा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् । खतरा फेरि आउँदैन भनेर कहिल्यै नभन्नुहोस् ।

5 सहयोगको बाटो खुला राख्नुहोस्

भन्नुहोस् *“निद्राको समस्या लम्बिएर दिनहरू गाहो बनाएमा तपाईं सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले पर्खनुपर्दैन ।”*

अभ्यास कार्डहरू (क्रमशः)

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

कसैले निद्राको चक्की मागेमा

> *"मलाई निद्राको चक्की ल्याइदिन सक्नुहुन्छ? मलाई बस सुत्न मन छ।"*

औषधि नदिनुहोस् वा सुझाव नदिनुहोस्; स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् (पृष्ठ २, नगर्नुहोस्; पृष्ठ ३)।

1 आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस्

भन्नुहोस्: *"म औषधि दिन वा सुझाव दिन सक्दिनँ, तर तपाईंको निद्राबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्न सहयोग गर्न सक्छु।"*

गर्नुहोस्: स्थानीय रूपमा जाँच गरिएको सम्पर्क बताउनुहोस् र साथै जाने प्रस्ताव गर्नुहोस्।

2 नराम्रो रात कस्तो हुन्छ भनेर सुन्नुहोस्

सोध्नुहोस्: *"नराम्रो रातमा प्रायः के हुन्छ?"*

3 आज रातका लागि पर्चाका एक-दुई सुझाव बताउनुहोस्

गर्नुहोस्: जस्तै टर्च र पानी नजिकै राख्ने, वा सुन्नुअघिको कुनै परिचित बानी। निदाउन रक्सी वा लागूपदार्थ प्रयोग गर्दा निद्रा झन् बिग्रन सक्छ भनेर नरम तरिकाले बताउनुहोस्।

4 उहाँ पहिलेदेखि डाक्टरको औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने

भन्नुहोस्: *"कृपया स्वास्थ्यकर्मीलाई नसोधी त्यो नछाड्नुहोस्।"*

अभिभावक रातमा बच्चाबारे चिन्तित हुँदा

> *"मेरो छोराले फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्न थालेको छ, र म नभई ऊ सुत्दैन।"*

पर्चा, *"रातमा बालबालिका"*।

1 यसलाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस्: *"डरलाग्दो समयपछि धेरै बालबालिकामा यस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ। नजिकै रहन खोज्नु र फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्नु सामान्य हो।"*

2 पर्चाका सुझावहरू बताउनुहोस्

गर्नुहोस्: बच्चालाई नजिकै रहन दिनुहोस्। सुन्नुअघि कथा वा गीतजस्तो छोटो दिनचर्या राख्नुहोस्। चेतावनी आएमा परिवारले के गर्छ भनेर सरल रूपमा बताउनुहोस्। ब्युँझिएकोमा वा ओछ्यानमा पिसाब फेरेकोमा बच्चालाई सजाय नदिनुहोस्।

3 अभिभावकबारे पनि सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस्: *"अनि तपाईंका आफ्नै रातहरू कस्ता छन्?"*

4 सहयोगको बाटो खुला राख्नुहोस्

गर्नुहोस्: यो लम्बिएर दिनहरू गाह्रो बनाएमा, वा अभिभावक यसबारे धेरै चिन्तित हुनुभएमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रस्ताव गर्नुहोस्।